



INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

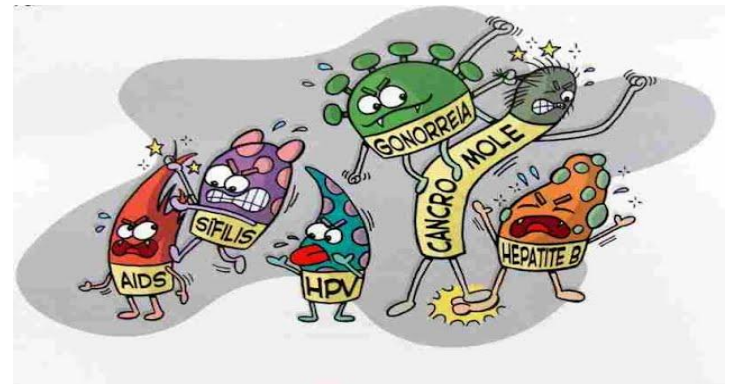
Iolanda Felipe da Silva Bona
Médica de Família e Comunidade
IESC VII



OBJETIVOS:

1. *Compreender o diagnóstico, o acompanhamento e as políticas públicas para as ISTs.*
2. *Abordar as manifestações clínicas e conduta para as ISTs.*
3. *Reconhecer a abordagem sindrômica das ISTs.*
4. *Identificar os determinantes de saúde ligados a esta patologia.*
5. *Conhecer a prevenção e rastreamento das ISTs.*

- São um importante problema de saúde pública, com magnitude reconhecida em todo o mundo, embora o registro de seus números nem sempre sejam precisos.
- A incidência tem aumentado tanto na população geral como entre os adolescentes.
- No Brasil, as estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) de infecções de transmissão sexual na população sexualmente ativa, a cada ano, são estas:
 - ❑ Sífilis – 937.000;
 - ❑ Gonorreia – 1.541.800;
 - ❑ Clamídia – 1.967.200;
 - ❑ Herpes genital – 640.900;
 - ❑ Vírus do papiloma humano (HPV) – 685.400.



- Os dois principais fatores de risco para IST são práticas sexuais sem uso de preservativos e idade mais baixa.
- Fatores como vergonha, medo e dificuldade de acesso aos serviços de saúde ampliam o risco de complicações e dificultam sua prevenção.
- Medidas de educação em saúde, pronto acesso ao diagnóstico e tratamento e ampliação ao acesso aos preservativos são de eficácia comprovada em todo o mundo para a prevenção das ISTs.
- A denominação doença sexualmente transmissível (DST) foi substituída no Brasil por infecção sexualmente transmissível (IST) pelo Decreto no 8.901/2016, para destacar a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas.



PROVÁVEL IST

- Quando pessoas que têm relações sexuais sem uso de preservativo se apresentam nos serviços de saúde com algum dos seguintes sinais e sintomas:

- ☐ Lesões genitais;
- ☐ Corrimentos vaginal e/ou uretral;
- ☐ Vesículas e/ou verrugas genitais;
- ☐ Edema e/ou dor escrotal.



RASTREAMENTO

- É a realização de testes diagnósticos em pessoas assintomáticas para estabelecer o diagnóstico precoce, com o objetivo de reduzir a morbimortalidade do agravo rastreado.
- Diferentemente de outros rastreamentos, não identifica apenas uma pessoa.
 - ❑ Está sempre ligado a uma rede de transmissão.
 - ❑ Quando não identificado e tratado o agravo na(s) parceria(s), este se perpetua na comunidade e expõe o indivíduo a reinfeção.



QUEM	QUANDO			
	HIV ^a	Sífilis ^b	Clamídia e gonococo ^c	Hepatites B ^d e C ^e
Adolescentes e jovens (≤30 anos)	Anual		Ver frequência conforme outros subgrupos populacionais ou práticas sexuais	
Gestantes	Na primeira consulta do pré-natal (idealmente, no 1º trimestre da gestação); No início do 3º trimestre (28ª semana); No momento do parto, ou em caso de aborto/natimorto, independentemente de exames anteriores Em caso de aborto/natimorto, testar para sífilis, independentemente de exames anteriores.	Na primeira consulta do pré-natal (Gestantes ≤ 30 anos)	Hepatite B: na primeira consulta do pré-natal (idealmente, no primeiro trimestre) ^f Hepatite C: na primeira consulta do pré-natal	
Gays e HSH	Semestral		Ver frequência conforme outros subgrupos populacionais ou práticas sexuais	Semestral a anual
Profissionais do sexo				
Travestis/ transexuais				
Pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas				
Pessoas com diagnóstico de IST	No momento do diagnóstico e 4 a 6 semanas após o diagnóstico de IST		No momento do diagnóstico	No momento do diagnóstico
Pessoas com diagnóstico de hepatites virais	No momento do diagnóstico	—	—	—
Pessoas com diagnóstico de tuberculose	No momento do diagnóstico	—	—	—
PVHIV	—	Semestral	No momento do diagnóstico	Semestral a anual
Pessoas com prática sexual anal receptiva (passiva) sem uso de preservativos	Semestral			Semestral a anual
Pessoas privadas de liberdade	Anual	Semestral	—	Semestral a anual

Violência sexual	No atendimento inicial; 4 a 6 semanas após exposição e 3 meses após a exposição	No atendimento inicial e 4 a 6 semanas após a exposição			Hepatite B: no atendimento inicial e de acordo com a profilaxia pós-exposição instituída ^g Hepatite C: no atendimento inicial, 4 a 6 semanas e 4 a 6 meses
Pessoas em uso de PrEP	Em cada visita ao serviço	Trimestral	Semestral	Trimestral	
Pessoas com indicação de PEP	No atendimento inicial; 4 a 6 semanas após exposição e 3 meses após a exposição	No atendimento inicial e 4 a 6 semanas após a exposição	No atendimento inicial e 4 a 6 semanas após exposição (exceto nos casos de acidente com material biológico)		Hepatite B: no atendimento inicial e de acordo com a profilaxia pós-exposição instituída ^g Hepatite C: no atendimento inicial, 4 a 6 semanas e 4 a 6 meses

CONDUTA PROPOSTA

- Atualmente, o principal a fazer é a abordagem integral das ISTs, combinando, quando disponível, o rastreamento e o tratamento das assintomáticas e o uso de fluxogramas nas sintomáticas, utilizando laboratório complementar.
- As principais manifestações clínicas das IST são: corrimento vaginal, corrimento uretral, úlceras genitais e verrugas anogenitais.

SÍNDROME – ÚLCERA ANOGENITAL

Possíveis agentes etiológicos	Infecção
<i>Chlamydia trachomatis</i> (sorovariantes L1, L2 e L3)	Linfogranuloma venéreo – LGV
<i>Haemophilus ducreyi</i>	Cancroide
Vírus do Herpes simplex (tipo 2)	Herpes genital ^a
<i>Klebsiela granulomatis</i>	Donovanose
<i>Treponema pallidum</i>	Sífilis

SÍNDROME – CORRIMENTO URETRAL/VAGINAL

Possíveis agentes etiológicos	Infecção
<i>Candida albicans</i>	Candidíase vulvovaginal ^b
<i>Chlamydia trachomatis</i> (sorovariantes D a K)	Clamídia
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Gonorreia
<i>Trichomonas vaginalis</i>	Tricomoniase
<i>Mycoplasma genitalium</i>	Infecção causada por micoplasma
Múltiplos agentes	Vaginose bacteriana ^b

SÍNDROME – VERRUGA ANOGENITAL

Possíveis agentes etiológicos	Infecção
Papilomavírus humano – HPV	Condiloma acuminado ^a

HERPES GENITAL



- A herpes genital é causada pelo vírus herpes simples (HSV).
 - ❑ O HSV1 predomina como causador das lesões genitais, e o HSV2 das lesões periorais.
- A maioria das infecções é subclínica (63-87%).
- Sua evolução é caracterizada por surtos recorrentes.
- A apresentação típica do herpes genital é a presença de múltiplas lesões vesiculares ou ulcerativas, dolorosas, com base avermelhada e intensamente pruriginosas.

- A primoinfecção tem quadro mais exuberante e acompanhado de sintomas gerais, tais como febre, mal-estar, adinamia e disúria.
- Em gestantes, aumenta o risco de complicações obstétricas, e a presença de lesões ativas pode indicar a via alta de parto, a fim de evitar a transmissão no canal do parto.
- Tem muita relação com aspectos emocionais do paciente.
- O isolamento do HSV em células de cultura é o teste mais preciso para o diagnóstico de condição em que há úlceras genitais ou lesões mucocutâneas.



- O tratamento é ineficaz em relação à cura, tendo por objetivo diminuir a intensidade e a duração dos surtos.

Condição clínica	Tratamento	Comentários
Primeiro episódio	Aciclovir 200mg, 2 comprimidos, VO, 3x/dia, por 7-10 dias, ou aciclovir 200 mg, 1 comprimido, VO, 5x/dia (7h, 11h, 15h, 19h, 23h, 7h...), por 7-10 dias	- Iniciar o tratamento o mais precocemente possível. - O tratamento pode ser prolongado se a cicatrização estiver incompleta após 10 dias de terapia.
Recidiva	Aciclovir 200mg, 2 comprimidos, VO, 3x/dia, por 5 dias, ou aciclovir 200mg, 4 comprimidos, VO, 2x/dia, por 5 dias	- O tratamento deve ser iniciado preferencialmente no período prodrômico (aumento de sensibilidade local, ardor, dor, prurido e hiperemia da região genital).
Supressão de herpes genital (6 ou mais episódios/ano)	Aciclovir 200mg, 2 comprimidos, VO, 2x/dia, por até 6 meses, podendo o tratamento ser prolongado por até 2 anos	- Consideram-se elegíveis para o tratamento supressivo pacientes com episódios repetidos de herpes genital (mais de 6 ao ano). - Indicada avaliação periódica de função renal e hepática.
Herpes genital em imunossuprimidos	Aciclovir endovenoso, 5-10 mg/kg de peso, EV, de 8/8h, por 5 a 7 dias, ou até resolução clínica	- Em caso de lesões extensas em pacientes com imunossupressão (usuários crônicos de corticoide, pacientes em uso de imunomoduladores, transplantados de órgãos sólidos e PVHIV), pode-se optar pelo tratamento endovenoso.
Gestação	Tratar o primeiro episódio em qualquer trimestre da gestação, conforme o tratamento para o primeiro episódio. Se a primoinfecção ocorreu na gestação ou se recidivas foram frequentes no período gestacional, pode-se realizar terapia supressiva, a partir da 36ª semana, com aciclovir 400mg, 3x/dia.	

SÍFILIS

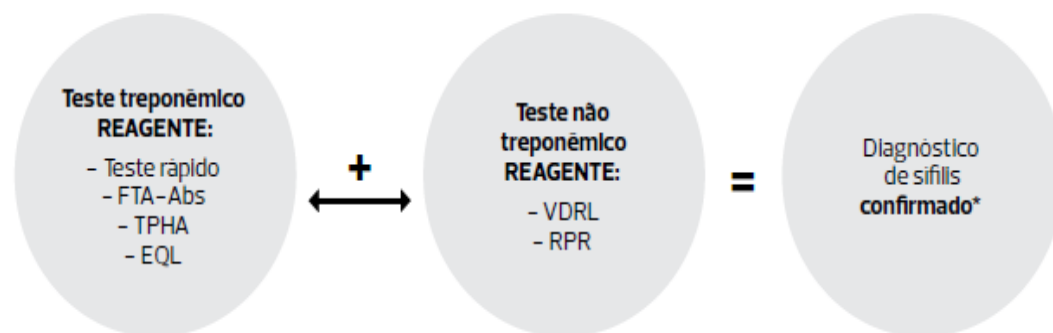


- É uma infecção bacteriana sistêmica, crônica, curável.
- Quando não tratada, evolui para estágios de gravidade variada, podendo acometer diversos órgãos e sistemas do corpo.
- Seu agente etiológico é o *Treponema pallidum*.
- Sua transmissão se dá principalmente por contato sexual; contudo, a infecção pode ser transmitida verticalmente para o feto durante a gestação.
- É obrigatória a notificação de todos os casos de sífilis (adquirida, gestacional, congênita).
- O Brasil apresenta uma reemergência da doença.



Estágios da sífilis		Tempo após a exposição	Manifestações clínicas
Recente	Primária	10 a 90 dias (média de 3 semanas)	Cancro duro (úlceras genitais) Linfonodos regionais
	Secundária	6 semanas a 6 meses após cicatrização do cancro duro ^a	Lesões cutâneo-mucosas (roséola, placas mucosas, sífilides papulosas, sífilides palmoplantares, condiloma plano, alopecia em clareira, madarose, rouquidão) Micropoliadenopatia Linfadenopatia generalizada Sinais constitucionais Quadros neurológicos, oculares, hepáticos
	Latente recente	Até 1 (um) ano de duração	Assintomática
	Latente tardia	Mais de 1 (um) ano de duração ^b	Assintomática
Tardia	Terciária	Entre 1 (um) e 40 anos	Cutâneas: lesões gomosas e nodulares, de caráter destrutivo Ósseas: periostite, osteíte gomosa ou esclerosante, artrites, sinovites e nódulos justarticulares Cardiovasculares: estenose de coronárias, aortite e aneurisma da aorta, especialmente da porção torácica Neurológicas: meningite, gomas do cérebro ou da medula, atrofia do nervo óptico, lesão do sétimo par craniano, manifestações psiquiátricas, <i>tabes dorsalis</i> e quadros demenciais, como o da paralisia geral

Toda pessoa com quadro de erupção cutânea sem causa determinada deve ser investigada com testes para sífilis.



IMPORTANTE

O diagnóstico de sífilis exige correlação entre dados clínicos, resultados de testes laboratoriais, histórico de infecções passadas e investigação de exposição recente.

*O VDRL pode ser falso-positivo de forma transitória na malária, na gravidez, na mononucleose infecciosa, nas viroses, na tuberculose.

Estadiamento	Esquema terapêutico	Alternativa ^a (exceto para gestantes)
Sífilis recente: sífilis primária, secundária e latente recente (com até um ano de evolução)	Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, dose única (1,2 milhão UI em cada glúteo)	Doxiciclina 100mg, 12/12h, VO, por 15 dias
Sífilis tardia: sífilis latente tardia (com mais de um ano de evolução) ou latente com duração ignorada e sífilis terciária	Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, 1x/semana (1,2 milhão UI em cada glúteo) por 3 semanas ^b . Dose total: 7,2 milhões UI, IM	Doxiciclina 100mg, 12/12h, VO, por 30 dias
Neurossífilis	Benzilpenicilina potássica/cristalina 18-24 milhões UI, 1x/ dia, EV, administrada em doses de 3-4 milhões UI, a cada 4 horas ou por infusão contínua, por 14 dias	Ceftriaxona 2g IV, 1x/dia, por 10-14 dias

Monitoramento	
Público	Período
Gestantes	Mensal (até o final da gestação)
População não gestante (incluindo PVHIV)	A cada 3 meses até o 12º mês (3, 6, 9, 12 meses)
Neurossífilis	Exame de LCR a cada 6 meses até a normalização da celularidade e VDRL não reagente

*O monitoramento deve ser realizado com teste não treponêmico e, sempre que possível, com a mesma metodologia utilizada no diagnóstico.

*Pode haver persistência de títulos baixos, a chamada “cicatriz sorológica”, que pode persistir pelo resto da vida.

CANCRO MOLE (CANCROIDE)



- É uma infecção bacteriana aguda causada por um bacilo aeróbico gram-negativo, *Haemophilus ducreyi*.
- O diagnóstico definitivo necessita ter a identificação do *H. ducreyi* (cultura).
- Um diagnóstico provável pode ser feito se todos os seguintes critérios forem contemplados:
 - ❑ Uma ou mais úlceras genitais dolorosas;
 - ❑ Ausência de evidência de infecção pelo *T. pallidum*;
 - ❑ Presença de linfadenopatia regional;
 - ❑ Teste negativo para HSV realizado na secreção da ulceração.

- As lesões são dolorosas, geralmente múltiplas e devidas à autoinoculação.
- A borda é irregular, apresentando contornos eritemato-edematosos e fundo heterogêneo, recoberto por exsudato necrótico, amarelado, com odor fétido, que, quando removido, revela tecido de granulação com sangramento fácil.

Condição clínica	Primeira opção	Alternativa	Comentários
Cancroide	Azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, dose única	Ceftriaxona 250mg, IM, dose única, ou ciprofloxacino ^b 500mg, 1 comprimido, VO, 2x/ dia, por 3 dias	- O tratamento sistêmico deve ser acompanhado de medidas locais de higiene. - O tratamento das parcerias sexuais é recomendado, mesmo quando assintomáticas, com azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, dose única.

DONOVANOSE (GRANULOMA INGUINAL)



- Doença genital progressiva e crônica que causa lesões granulomatosas destrutivas, cujo agente etiológico é a *Klebsiella granulomatis*.
- A doença inicia-se com uma lesão nodular subcutânea única ou múltipla, que evolui para úlcera bem definida, indolor, que sangra facilmente.
- O diagnóstico é feito quando corpúsculos de Donovan estão presentes em esfregaço ou biópsia da lesão, corado com Giemsa ou Wright.

Condição clínica	Primeira opção	Alternativa	Comentários
Donovanose	Azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, 1x/semana, por pelo menos 3 semanas, ou até a cicatrização das lesões	Doxiciclina ^a 100mg, 1 comprimido, VO, 2x/dia, por pelo menos 21 dias, ou até o desaparecimento completo das lesões, ou ciprofloxacino ^b 500mg, 1 e 1/2 comprimido, VO, 2x/dia, por pelo menos 21 dias, ou até a cicatrização das lesões (dose total: 750mg), ou sulfametoxazol-trimetoprima (400/80mg), 2 comprimidos, VO, 2x/dia, por no mínimo 3 semanas, ou até a cicatrização das lesões	- Não havendo resposta na aparência da lesão nos primeiros dias de tratamento com ciprofloxacino^b, recomenda-se adicionar um aminoglicosídeo, como a gentamicina, 1mg/kg/dia, EV, 3x/dia, por pelo menos três semanas, ou até cicatrização das lesões. - Em PVHIV, sugerem-se os mesmos esquemas terapêuticos; o uso de terapia parenteral com a gentamicina deve ser considerado nos casos mais graves. - O critério de cura é o desaparecimento da lesão, não tendo sido relatada infecção congênita. As sequelas da destruição tecidual ou obstrução linfática podem exigir correção cirúrgica. - Devido à baixa infectividade, não é necessário tratar as parcerias sexuais.

LINFOGRANULOMA VENÉREO

- É uma doença infecciosa de transmissão exclusivamente sexual, causada pela *Chlamydia trachomatis*, sorotipos L1, L2 e L3.
- A doença se apresenta em três fases:
 - ❑ A lesão de inoculação inicia-se com uma pápula, pústula ou ulceração indolor, que desaparece sem deixar sequelas.
 - ❑ A disseminação linfática regional se desenvolve entre 1 e 6 semanas após a lesão inicial, sendo geralmente unilateral. Os gânglios podem fundir-se, com supuração e fistulização por orifícios múltiplos.
 - ❑ Como sequelas podem ocorrer a elefantíase genital, fístulas retais, vaginais ou vesicais e estenose retal.
- Na maioria das vezes, o diagnóstico é clínico.

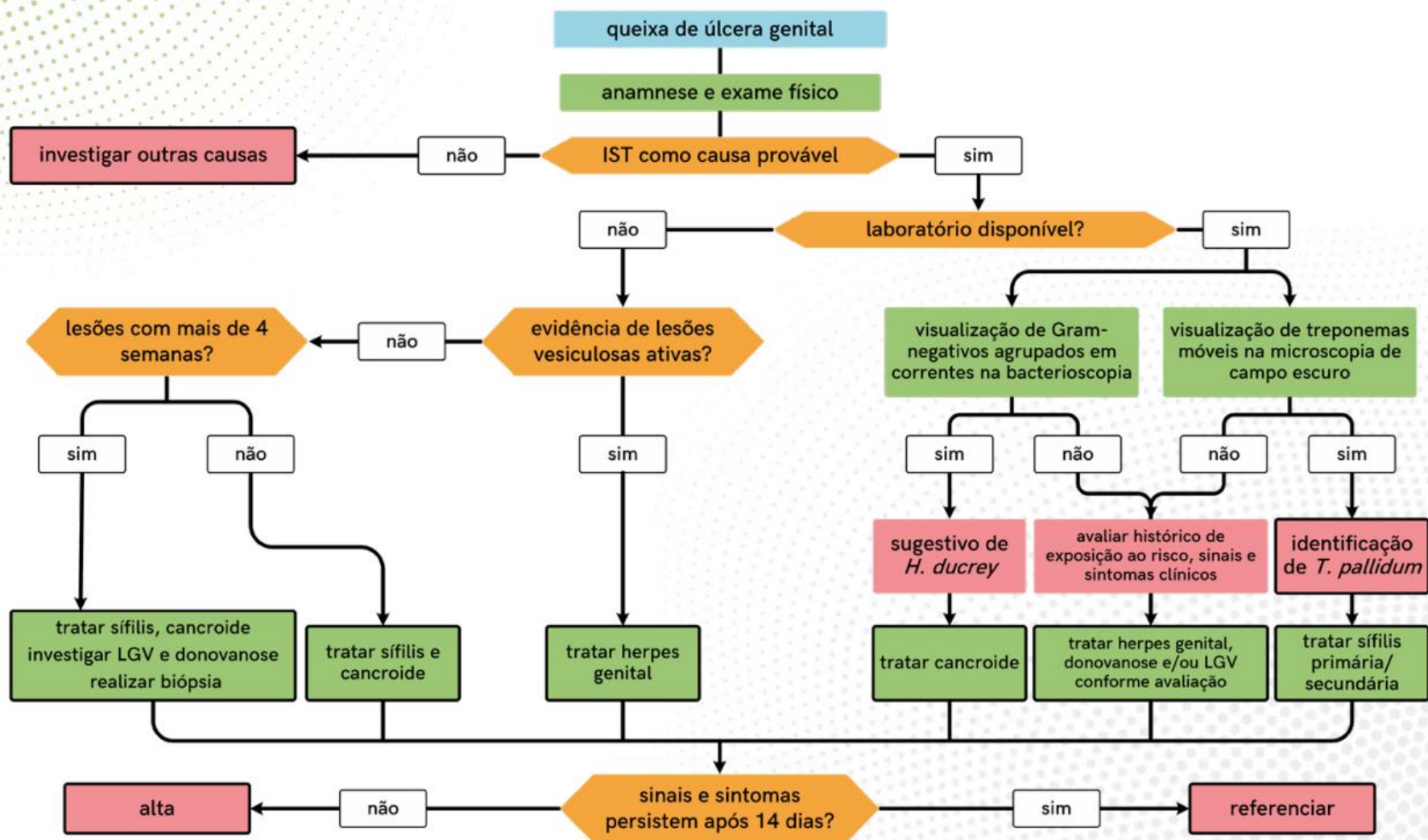


- O diagnóstico de LGV deve ser considerado sempre que houver adenite inguinal, elefantíase genital e estenose uretral ou retal.



- O teste de fixação de complemento (teste sorológico) é grupo-específico, ou seja, identifica anticorpos contra todas as infecções por clamídia.

Condição clínica	Primeira opção	Alternativa	Comentários
Linfogranuloma venéreo (LGV)	Doxiciclina ^a 100mg, VO, 1 comprimido, 2x/dia, por 21 dias	Azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, 1x/semana, por 21 dias (preferencial nas gestantes)	- As parcerias sexuais devem ser tratadas. Se a parceria for sintomática, o tratamento deve ser realizado com os mesmos medicamentos do caso-índice. Se a parceria for assintomática, recomenda-se um dos tratamentos abaixo: - Azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, dose única, ou doxiciclina^a 100mg, 1 comprimido, VO, 2x/ dia, por 7 dias. - O prolongamento da terapia pode ser necessário até a resolução da sintomatologia. A antibioticoterapia não tem efeito expressivo na duração da linfadenopatia inguinal, mas os sintomas agudos são frequentemente erradicados de modo rápido. Os antibióticos não revertem sequelas como estenose retal ou elefantíase genital.



queixa de corrimento vaginal

anamnese e exame ginecológico (toque e exame especular)

História clínica: avaliar práticas sexuais e fatores de risco para IST, data da última menstruação, práticas de higiene vaginal e uso de medicamentos tópicos ou sistêmicos e/ou outros potenciais agentes irritantes locais.

Fluxo vaginal: consistência, cor e alterações no odor do corrimento, presença de prurido e/ou irritação local.

dor à mobilização do colo uterino, material mucopurulento no orifício externo do colo, edema cervical e sangramento ao toque da espátula ou *swab*?

sim

investigar cervicite/DIP
tratar clamídia
e gonorreia

não

microscopia a fresco disponível na consulta?

sim

corrimento vaginal confirmado?

não

sim

não

pH vaginal e/ou KOH a 10% disponível?

coleta de material
para microscopia^a

presença de *clue cells*

tratar vaginose
bacteriana

presença de
Trichomonas sp

tratar tricomoniase

presença de hifas

tratar candidíase

não

sim

pH >4,5 e/ou KOH (+)

pH <4,5 e/ou KOH (-)

corrimento grumoso ou eritema vulvar?

sim

não

tratar candidíase

causa fisiológica

tratar vaginose bacteriana e
tricomoniase

avaliar se o exame preventivo de câncer
de colo do útero está em dia

^aQuando realizada coleta
para microscopia por
coloração de Gram,
considerar o resultado para
manejo do caso.

Condição clínica	Primeira opção	Segunda opção	Comentários
Candidíase vulvovaginal (CVV)	Miconazol creme a 2% ou outros derivados imidazólicos, via vaginal, um aplicador cheio, à noite ao deitar-se, por 7 dias, ou nistatina 100.000 UI, uma aplicação, via vaginal, à noite ao deitar-se, por 14 dias	Fluconazol 150mg, VO, dose única, OU itraconazol 100mg, 2 comprimidos, VO, 2x/dia, por 1 dia	- As parcerias sexuais não precisam ser tratadas, exceto as sintomáticas. - É comum durante a gestação, podendo haver recidivas. - Tratamento em gestantes e lactantes: somente por via vaginal. - O tratamento oral está contraindicado. - CVV recorrente: paciente reporta quatro ou mais episódios sintomáticos em um ano^a.
Vaginose bacteriana (VB)	Metronidazol 250mg, 2 comprimidos VO, 2x/dia, por 7 dias, ou metronidazol gel vaginal 100mg/g, um aplicador cheio via vaginal, à noite ao deitar-se, por 5 dias	Clindamicina 300mg, VO, 2x/dia, por 7 dias	- O tratamento das parcerias sexuais não está recomendado. - Para as gestantes, lactantes e puérperas, recomenda-se o mesmo tratamento de primeira opção. - A recorrência de VB após o tratamento é comum^b.
Tricomoníase	Metronidazol 400mg, 5 comprimidos, VO, dose única (dose total 2g), ou metronidazol 250mg, 2 comprimidos, VO, 2x/dia, por 7 dias	-	- As parcerias sexuais devem ser tratadas com o mesmo esquema terapêutico. - As gestantes, lactentes e puérperas devem ser tratadas com o mesmo esquema terapêutico.

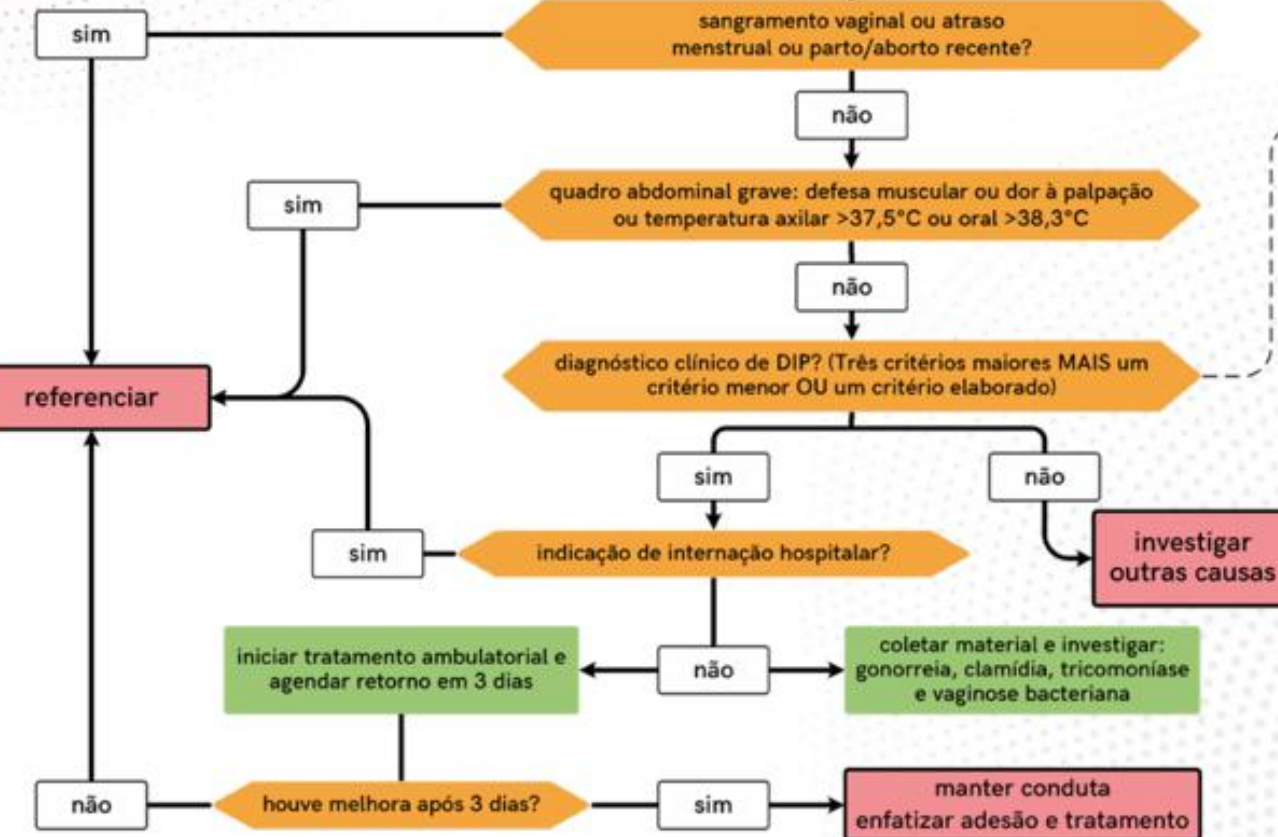
Cervicite

Cervicite sem identificação do agente etiológico	Ceftriaxona 500mg, IM, dose única, mais azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, dose única
Cervicite gonocócica	Ceftriaxona 500mg, IM, dose única, mais azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, dose única
Cervicite por clamídia	Azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, dose única, ou doxiciclina ^a 100mg, 1 comprimido, VO, 2x/ dia, por 7 dias
Cervicite por <i>Mycoplasma genitalium</i>	Azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, 2x/dia, por 7 dias

queixa de dor abdominal baixa aguda ou dor pélvica aguda

História clínica: avaliar práticas sexuais e fatores de risco para IST, inserção de DIU ou biópsia de endométrio ou curetagem, entre outros.

anamnese e exame ginecológico (toque vaginal e exame especular)



CRITÉRIOS MAIORES

- Dor no hipogástrico
- Dor à palpação dos anexos
- Dor à mobilização de colo uterino

CRITÉRIOS MENORES

- Temperatura axilar >37,5°C ou temperatura oral >38,3°C
- Conteúdo vaginal ou secreção endocervical anormal
- Massa pélvica
- Mais de dez leucócitos por campo de imersão em material de endocérvice
- Leucocitose em sangue periférico
- Proteína C reativa ou velocidade de hemossedimentação (VHS) elevada
- Comprovação laboratorial de infecção cervical por gonococo, clamídia ou micoplasmas

CRITÉRIOS ELABORADOS

- Evidência histopatológica de endometrite
- Presença de abscesso tubo-ovariano ou de fundo de saco de Douglas em estudo de imagem
- Laparoscopia com evidência de DIP

CRITÉRIOS PARA INDICAÇÃO DE TRATAMENTO HOSPITALAR DE DIP

- Abscesso tubo-ovariano;
- Gravidez;
- Ausência de resposta após 72h do início do tratamento com antibioticoterapia oral;
- Intolerância a antibióticos orais ou dificuldade para seguimento ambulatorial;
- Estado geral grave, com náuseas, vômitos e febre;
- Dificuldade na exclusão de emergência cirúrgica (ex.: apendicite, gravidez ectópica).

Tratamento	Primeira opção	Segunda opção	Terceira opção
Ambulatorial	Ceftriaxona 500mg, IM, dose única, mais doxiciclina ^a 100mg, 1 comprimido, VO, 2x/dia, por 14 dias, mais metronidazol 250mg, 2 comprimidos, VO, 2x/dia, por 14 dias	Cefotaxima 500mg, IM, dose única, mais doxiciclina ^a 100mg, 1 comprimido, VO, 2x/dia, por 14 dias, mais metronidazol 250mg, 2 comprimidos, VO, 2x/dia, por 14 dias	-
Hospitalar	Ceftriaxona 1g, IV, 1x/dia, por 14 dias, mais doxiciclina ^a 100mg, 1 comprimido, VO, 2x/dia, por 14 dias, mais metronidazol 400mg, IV, de 12/12h	Clindamicina 900mg, IV, 3x/dia, por 14 dias, mais gentamicina (IV ou IM): 3-5 mg/kg, 1x/dia, por 14 dias	Ampicilina/sulbactam 3g, IV, 6/6h, por 14 dias, mais doxiciclina ^a 100mg, 1 comprimido, VO, 2x/dia, por 14 dias

- As parcerias sexuais dos dois meses anteriores ao diagnóstico, sintomáticas ou não, devem ser tratadas empiricamente para *Neisseria gonorrhoeae* e *Chlamydia trachomatis*. Recomenda-se ceftriaxona 500mg IM, associada a azitromicina 1g VO, ambas em dose única.
- Mulheres grávidas com suspeita de DIP têm alto risco de abortamento e corioamnionite. Todas as gestantes com suspeita ou com DIP confirmada devem ser internadas e iniciar imediatamente antibióticos intravenosos de amplo espectro.
- Se a paciente for usuária de DIU, não há necessidade de remoção do dispositivo; porém, caso exista indicação, a remoção não deve ser anterior à instituição da antibioticoterapia, devendo ser realizada somente após duas doses do esquema terapêutico.
- DIP em pessoas imunocomprometidas: comportamento similar às pacientes com imunidade normal, apenas com a ressalva de que desenvolvem mais facilmente abscesso tubo-ovariano, merecendo, portanto, maior cuidado, sem necessidade de internação.

queixa de corrimento uretral

anamnese e exame clínico

História clínica: avaliar práticas sexuais e fatores de risco para IST, uso de produtos e/ou objetos na prática sexual.

Aspecto do corrimento: mucopurulento, com volume variável, associado a dor uretral (independentemente da micção), disúria, estrangúria (micção lenta e dolorosa), prurido uretral e eritema de meato uretral.

laboratório disponível?

sim

não

coleta de material para
microscopia (Gram) e para cultura
e/ou biologia molecular^a

Quando disponíveis testes de
biologia molecular rápida,
tratar conforme achado.

tratar gonorreia e
clamídia^b

presença de diplococos gram-
negativos intracelulares (Gram)?

não

sim

tratar clamídia^b

tratar gonorreia e
clamídia^b

sinais e sintomas persistem após 7 dias?

sim

não

alta

sinais e sintomas persistem após 7 dias?

não

alta

sim

Verificar **resultado de cultura e/**
ou biologia molecular, quando
realizados.

Tratar gonorreia e/ou clamídia
etiologicamente caso não tenham
sido tratadas anteriormente.
Tratar também *Trichomonas*
vaginalis.

Excluir reinfecção, tratamento inadequado para clamídia
e gonorreia, resistência antimicrobiana, trauma, irritação
química ou inserção de corpos estranhos.

sinais e sintomas persistem após 14 dias?

não

sim

referenciar ao serviço
especializado

Condição clínica	Primeira opção	Segunda opção
Uretrite sem identificação do agente etiológico	Ceftriaxona 500mg, IM, dose única, mais azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, dose única	Ceftriaxona 500mg, IM, dose única, mais doxiciclina 100mg, 1 comprimido, VO, 2x/dia, por 7 dias
Uretrite gonocócica e demais infecções gonocócicas não complicadas (uretra, colo do útero, reto e faringe)	Ceftriaxona 500mg, IM, dose única, mais azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, dose única	-
Uretrite não gonocócica ^a	Azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, dose única	Doxiciclina ^a 100mg, 1 comprimido, VO, 2x/dia, por 7 dias
Uretrite por clamídia ^a	Azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, dose única	Doxiciclina ^a 100mg, 1 comprimido, VO, 2x/dia, por 7 dias
Retratamento de infecções gonocócicas ^b	Ceftriaxona 500mg, IM, dose única, mais azitromicina 500mg, 4 comprimidos, VO, dose única	Gentamicina 240mg, IM, mais azitromicina 500mg, 4 comprimidos, VO, dose única
Uretrite por <i>Mycoplasma genitalium</i>	Azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, dose única	-
Uretrite por <i>Trichomonas vaginalis</i>	Metronidazol 250mg, 2 comprimidos VO, 2x/dia, por 7 dias	Clindamicina 300mg, VO, 2x/dia, por 7 dias

CONDILOMA ACUMINADO (PAPILOMAVÍRUS HUMANO)

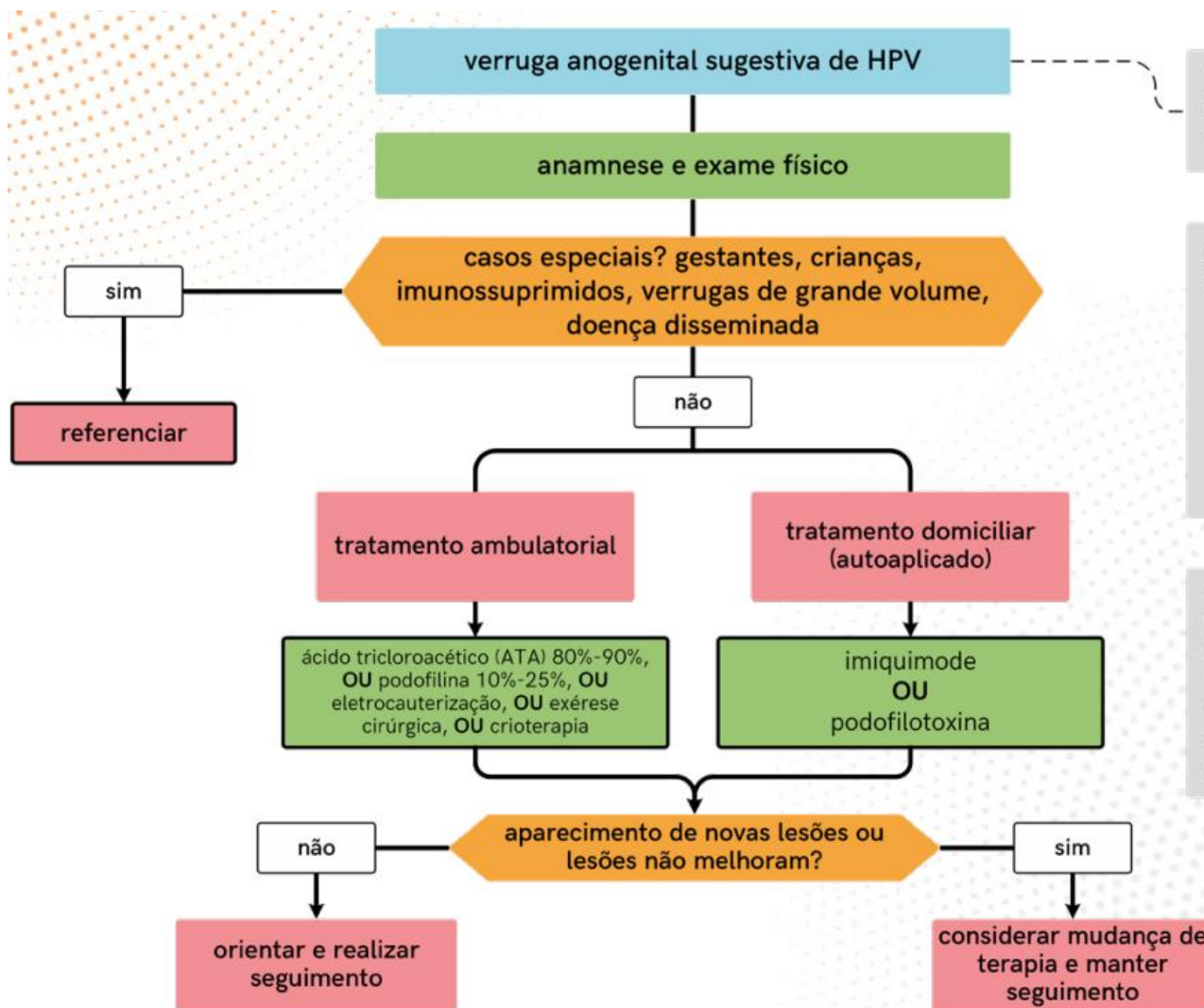
- A infecção pelo HPV é a IST viral mais frequente.
- Os tipos de HPV que infectam o trato genital são divididos em dois grupos, de acordo com seu potencial oncogênico e as lesões as quais costumam estar associados:
 - ❑ Baixo risco: tipos 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72 e 81.
 - ❑ Alto risco: tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 e 82.



- A vacinação é uma opção segura e eficaz na prevenção da infecção pelo HPV e suas complicações.
 - Tipos 6, 11, 16 e 18.
- Em mulheres, o HPV associa-se com risco aumentado para câncer de colo uterino.
- A maioria das mulheres infectadas pelo HPV é assintomática, e, com frequência, a infecção regride espontaneamente sem nenhum tipo de tratamento específico.
- Entretanto, em alguns casos, pode manifestar-se como uma lesão genital, também conhecida como verruga genital ou “crista de galo”.



- O diagnóstico do condiloma é basicamente clínico.
- A biópsia da lesão é realizada em casos excepcionais, em que exista dúvida diagnóstica.
- A citologia cervical não detecta o vírus do HPV, mas pode identificar alterações celulares possivelmente ocasionadas por ele.
- Se deixados sem tratamento, os condilomas podem desaparecer, permanecerem inalterados ou aumentarem em tamanho ou número.
- O principal objetivo do tratamento do condiloma é a remoção das lesões.



Lesões: polimórficas, pontiagudas, únicas ou múltiplas, achatadas ou papulosas, semelhantes a couve-flor.

Situações em que há indicação de biópsia para estudo histopatológico:

- Dúvida diagnóstica, suspeita de neoplasias ou outras doenças;
- Lesões atípicas ou que não respondam adequadamente aos tratamentos;
- Lesões suspeitas em pessoas com imunodeficiências.

Mulheres com verrugas anogenitais: realizar exame ginecológico completo, incluindo o exame preventivo de câncer de colo do útero e, quando indicada pelas alterações citológicas, colposcopia, acompanhada ou não de biópsia.

Pacientes com lesões anais: exame proctológico com anoscopia e toque retal.

PROGNÓSTICO E COMPLICAÇÕES POSSÍVEIS

- As ISTs, com exceção das causadas por vírus, são curáveis, desde que seguido o tratamento adequado.
- As medidas de prevenção devem ser adotadas para evitar-se a recontaminação.
- A sífilis não tratada depois da fase de latência pode levar a lesões cutaneomucosas, cardiovasculares e neurológicas.
 - ❑ Nas gestantes, pode levar ao abortamento, à morte intrauterina e à sífilis congênita.

- A infecção herpética primária no final da gestação oferece maior risco de infecção neonatal.
- Na donovanose a destruição tecidual e a obstrução linfática podem necessitar de intervenção cirúrgica.
- As cervicites na gestação podem levar a parto prematuro, à rotura prematura de membranas e à infecção fetal.
- A DIP é importante causa de infertilidade em mulheres, quando não tratada adequadamente.
- Entre os homens, as ISTs podem causar também infertilidade, carcinoma de pênis e de ânus, entre outras complicações.

Referências Bibliográficas:

GUSSO, G, et al. Tratado de medicina de família e comunidade - 2 volumes: princípios, formação e prática. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Grupo A, 2019. Cap. 140.

DUNCAN, B, B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. Disponível em: Minha Biblioteca, (5th edição). Grupo A, 2022. Cap. 140.



"Se você trata uma doença,
você pode ganhar ou perder.

Se você trata um paciente,
eu tenho certeza que você
sempre irá ganhar, não
importa o desfecho."

Patch Adams



Obrigada!